

· 药物不良反应 ·

喹诺酮类药物不良反应和药物相互作用探讨

李旭东

【关键词】 喹诺酮; 不良反应; 药物相互作用

【中图分类号】 R 978.1 【文献标识码】 B 【文章编号】 1674-3296(2011)02A-0090-01

喹诺酮类药物是人工合成药物,由于该类药抗菌谱广、抗菌活性强、给药方便等特点,临床应用较广泛,同时相关的一些不良反应报道也日渐增多^[1]。现就喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用报道如下。

1 不良反应

1.1 消化系统不良反应 胃肠道反应是喹诺酮类药物最常见的不良反应之一,主要表现为恶心、呕吐、腹泻、食欲不振及消化不良等,有的患者还会出现黄疸及血清转氨酶升高^[2]。对肝脏有一定毒性。

1.2 变态反应 临床表现为皮疹、荨麻疹、红斑、瘙痒、血管水肿、表皮松懈症等,严重者可出现剥脱性皮炎,也有出现过过敏性休克的报道^[3]。其机制是由光毒性反应引起的。在紫外线激发下喹诺酮类药物氧化生成活性氧,活性氧激发了皮肤纤维细胞中的蛋白激酶 C 和酪氨酸激酶,蛋白激酶 C 和酪氨酸激酶又激活环氧化酶,引起前列腺素类物质及环氧化酶的合成,其从成纤维细胞中释放,引起皮肤炎症^[4]。

1.3 关节软骨的不良反应 喹诺酮类药物的软骨毒性是医学界关注的焦点,左氧氟沙星对幼龄动物关节软骨具有毒性,主要发生在负重关节上,其中膝关节受累明显,典型症状是关节疼痛、肿胀僵硬,对成年动物无影响。临床报道未成年人服用左氧氟沙星后引起关节疼痛、肿胀,从而限制了该药在儿童、青少年、孕妇、哺乳期妇女中的应用。关于喹诺酮类药物引起幼龄动物软骨毒性的机制还不十分明确^[5]。

1.4 神经系统的不良反应 临床上表现为头痛、眩晕、耳鸣、听力下降、视力下降、烦躁、抽搐及癫痫发作等。最近有报道喹诺酮类药物左氧氟沙星可引起神经系统紊乱和精神异常,其不良反应机制是该药的脂溶性高能通过血脑屏障进入大脑组织,可抑制 γ -氨基丁酸(GABA)与受体结合,从而提高中枢神经系统的兴奋性^[6]。

1.5 心血管系统、泌尿系统的不良反应 心血管系统表现为心慌、心悸、血压升高、心肌缺血、心肌炎等,有时伴有心律失常,对心脏有一定毒性;对泌尿系统表现为肾毒性,引起结晶尿、血尿、尿素氮升高,可发生肾炎、急性肾功能衰竭等^[7]。

1.6 肝、肾毒性 一般来说,患者对喹诺酮类药物耐受性良好。使用环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星等血浆肌酐浓度升高的发生率为 0.2%~1.3%。这些药不会诱发结晶尿、间质性肾炎和急性肾功能障碍。虽然喹诺酮类药物诱发肾功能障碍的发生率低,但其造成的后果严重,曾有报道因使用氧氟沙星出现少尿。所以在使用喹诺酮类药物特别对肾功能不全的老年患者,不可掉以轻心。肝毒性也很罕见,肝功能异常发生率为 1.5%,多为一过性。

1.7 其他不良反应 喹诺酮类药物不良反应造成的跟腱损伤也屡有报道。应警惕儿童永久性软组织损伤。另外呼吸系统的不良反应表现为喉头阻塞感、呼吸困难、支气管炎、支气管痉挛等。

2 药物相互作用

2.1 与其他抗菌药物合用^[8] (1) 氨基糖苷类:这两类药物对于革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发生其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。(2) β -内酰胺类: β -内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。(3) 利福平:利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后使喹诺酮类抗菌活性降低,甚至消失。(4) 其他抗菌药类:合用使药效相加^[9]:与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌的作用。环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分枝杆菌具有协同作用。诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。合用使不良反应增加:喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可导致效用降低,不良反应加重。环丙沙星与阿霉素、万古霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 与其他类药物的相互作用 多价阳离子如镁、铝、钙、铁等均可降低本类药物的口服生物利用度。可与本类药物发生相互作用的药物主要有抗凝剂、非甾体类抗炎药,抗酸剂、硫糖铝、环孢素、茶碱和铁剂等。

综上所述,临床应用抗感染药物种类繁多,仅抗生素就 200 多种,如此众多的抗感染药物大量应用,不可避免出现一些问题。据专家统计,抗感染药处方中有 50% 以上无必要或使用不当,滥用程度更甚。因而明确药物耐药性、不良反应、相互作用与明确疗效同样重要。

参考文献

- 方翼. 3 种氟喹诺酮类药物抗生素后效应的研究 [J]. 中国抗生素杂志, 2006, 22(1): 67-68.
- 苏美庆, 朱海霞. 喹诺酮类抗菌药物的严重不良反应 [J]. 临床合理用药杂志, 2010, 3(15): 143.
- 江复. 氟喹诺酮类药物临床应用进展 [J]. 中华内科杂志, 2008, 38(8): 65-66.
- 陶然. 司帕沙星致日光性皮炎 1 例 [J]. 中国新药杂志, 2006, 8(6): 36-38.
- 王倩, 柳晓蕊. 试析喹诺酮类抗菌药物的不良反应 [J]. 临床合理用药杂志, 2009, 2(13): 24.
- 吴荷芳. 氟喹诺酮类药物不良反应分析 [J]. 中国医院药学杂志, 2007, 19(12): 76-77.

作者单位: 224161 江苏省大丰市三龙中心卫生院

(收稿日期: 2010-11-27)